



STATUS EPILEPTICUS

Behandlingsschemat avser vuxen patient med konvulsivt status epilepticus som pågått ≥ 5 minuter. Kontrollera och säkra ABC, sök orsak till status epilepticus.

pre - hospitalt	Midazolam 10 mg im, i andra hand Stesolid (diazepam) 10 mg rektalt eller Buccolam 10 mg bukkalt.
	↓ anfallet fortsätter ↓
på akutmottagningen	Ativan (lorazepam) 4 mg iv eller Stesolid (diazepam) 10 mg iv. Överväg lägre dos vid hög ålder, låg kroppsvikt (≤ 40 kg) eller hög risk för andningspåverkan. Dosen upprepas en gång om patienten inte har fått behandling prehospitalt.
	↓ anfallet fortsätter ↓
	Pro-Epanutin (fosfenytoin) 20 mg FE/kg iv (max 1500 mg FE, 150 mg FE/min) eller Ergenyl (valproat) 40 mg/kg iv (max 3000 mg, ges under 10-15 min) eller Keppra (levetiracetam) 60 mg/kg iv (max 4500 mg, ges under 10-15 min).
	↓ anfallet fortsätter ↓
IVA	Till IVA i samråd med narkosläkare för sövning med Propofol (bolus 2-3 mg/kg följt av infusion 1-3 mg/kg/tim) och intubering. Sikta på klinisk anfallsfrihet och inled EEG-övervakning så snart som möjligt.

Rekommendationen ersätter inte lokala/regionala riktlinjer. Det är vårdgivarens och den behandlande läkarens ansvar att vård och behandling ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Inga anspråk kan framställas mot föreningen Akut Neurologi i Sverige i detta avseende. Gäller kortets fram- och baksida. Reviderad år 2020.

Vikt (kg)	Midazolam (mg im)	Lorazepam (mg iv)	Stesolid (mg iv)	Pro-Epanutin (mgFE iv)	Valproat (mg iv)	Levetiracetam (mg iv)	Propofol bolus (mg iv)	infusion (mg/h iv)
≥80	10	4	10	1500	3000	4500	160-240	80-240
70	10	4	10	1400	2800	4200	140-210	70-210
60	10	4	10	1200	2400	3600	120-180	60-180
50	10	4	10	1000	2000	3000	100-150	50-150
40	5	2	8	800	1600	2400	80-120	40-120
Infusionstakt: Serumkoncentration, normalt terapeutiskt intervall: vid status epilepticus bör man sikta mot övre delen av intervallet.				150 mgFE/min 40-80 µmol/L	10-15 min 300-700 µmol/L	10-15 min Etablerat målintervall saknas	bolus -	1-15 mg/kg/h -